ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN PERSONAS CON DM2

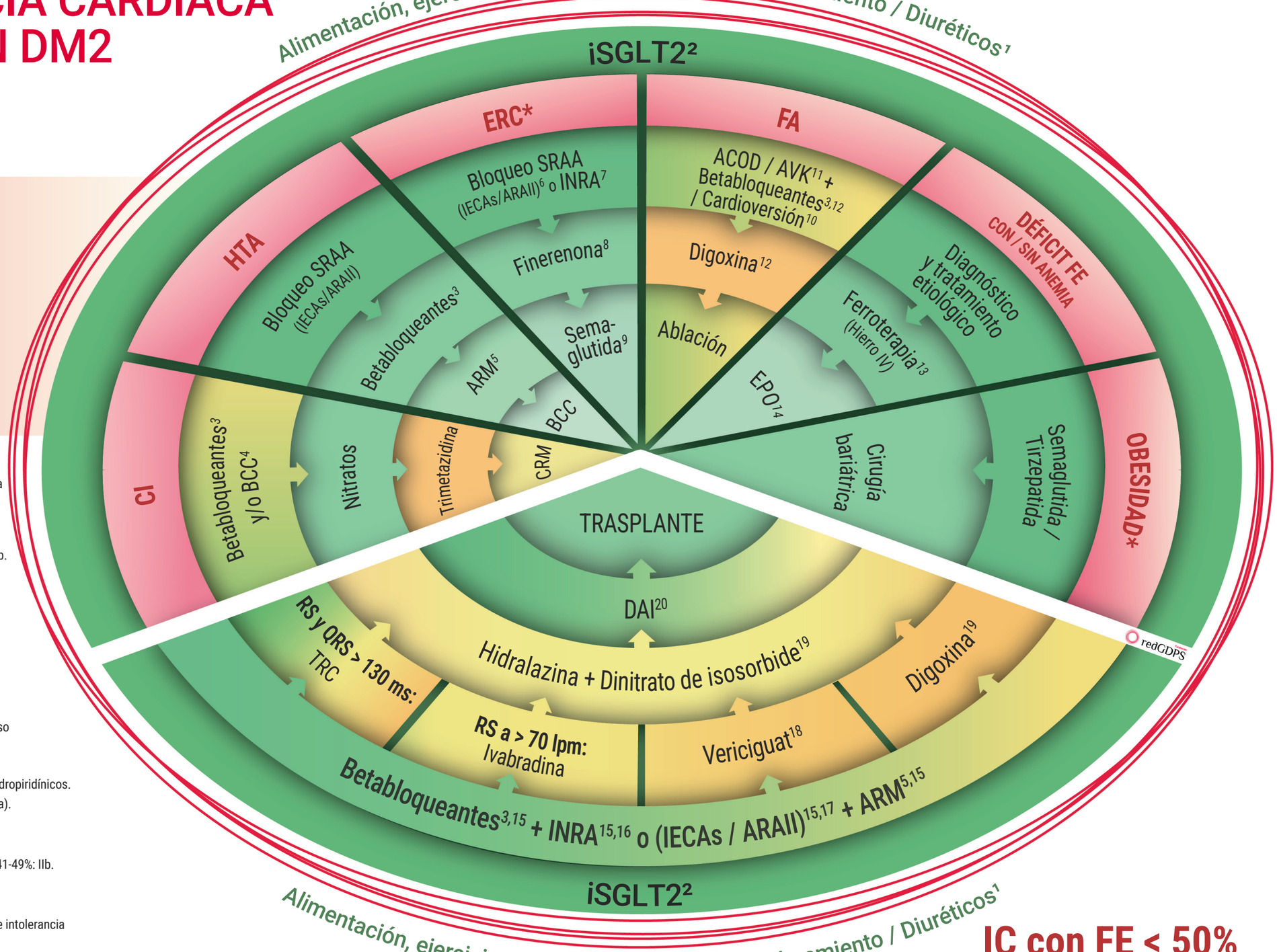
Fundación redGDPS 2025

* ver algoritmos específicos (ERC, OBESIDAD)

Las flechas indican progresión de la enfermedad o persistencia de síntomas.

EVITAR

- x BCC no dihidropiridínicos (verapamilo / diltiazem) salvo en presencia de FA con FEVI ≥ 40%.
- x Moxonidina.
- x Alfabloqueantes.
- x Combinar IECAs y ARA II entre sí o con INRA o aliskiren.
- x Combinar INRA con IECAs o ARA II o aliskiren.
- x Glitazonas y saxagliptina.
- x Antidepresivos tricíclicos.
- x AINES o inhibidores COX2.
- x Producir sarcopenia.



1. Dosis mínima necesaria para el control de la congestión, si precisa. De elección diuréticos de asa (IV en estadios 4 ó 5). En IC descompensada con sobrecarga de volumen añadir acetazolamida o hidroclorotiazida.
2. Salvo contraindicación. Asociar METFORMINA u otros ADO al iSGLT2, en caso necesario para el control glucémico.
3. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinato o nebivolol. En FEVI 41-49%: IIb.
4. Amlodipino, verapamilo o diltiazem. Si intolerancia a betabloqueantes: nicorandil o ranolazina.
5. Finerenona de elección en FEVI ≥ 40%, eplerenona, espironolactona.
6. Con vigilancia del K+ y TFG.
7. En IC-FEr mejor perfil renal que IECAs/ARA II, vigilando la hipotensión arterial.
8. En presencia de albuminuria.
9. En presencia de obesidad y albuminuria.
10. Considerar la cardioversión eléctrica o farmacológica (amiodarona) en caso de inestabilidad hemodinámica.
11. De elección ACOD por su mayor evidencia y seguridad.
12. Si persiste FC elevada. Si FEVI preservada también de utilidad BCC no dihidropiridínicos.
13. En IC con FEVI <50% de elección hierro IV (carboximaltosa o derisomaltosa).
14. Si anemia en ERC, una vez corregida la ferropenia.
15. En IC con FEVI entre 41 y 49%: Clase IIb, ≤ 40% Clase Ia.
16. Con mejor comportamiento glucémico que IECAs/ARAII en DM2. En FEVI 41-49%: IIb.
17. Si sigue sintomático, cambiar a INRA. En FEVI 41-49%: IIb.
18. Tras hospitalización reciente que haya precisado diuréticos IV.
19. Si persisten síntomas refractarios pese al tratamiento óptimo o en caso de intolerancia o contraindicación a INRA o IECAs/ARA II.
20. Si síntomas NYHA II-III tras tratamiento médico óptimo y expectativa de vida mayor de 1 año. Con cardiopatía isquémica (Clase I), no isquémica (Clase IIa).

IC con FE < 50%

GRADO DE RECOMENDACIÓN

I IIa IIb III

ABREVIATURAS:
ACOD: anticoagulantes orales directos; ADO: antidiabéticos orales; AINES: antiinflamatorios no esteroideos; ARAII: antagonistas de los receptores de la Angiotensina II; ARM: antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides; AVK: antagonistas de la vitamina K; BCC: bloqueadores de los canales del calcio; CI: cardiopatía isquémica; COX-2: ciclooxigenasa-2; CRM: cirugía de revascularización miocárdica; DAI: desfibrilador automático implantable; EPO: Agentes estimulantes de la Eritropoyetina; ERC: enfermedad renal crónica; FA: fibrilación auricular; FC: frecuencia cardiaca; Fe: hierro; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; IC: insuficiencia cardiaca; IC-FEr: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; INRA: inhibidores de la neprilisina y del receptor de angiotensina II; iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; IV: intravenoso; K+: potasio; QRS: complejo electrocardiográfico QRS; RS: ritmo sinusal; SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; TFG: tasa de filtrado glomerular; TRC: terapia de resincronización cardiaca.

© redGDPS https://redgdps.org/licencia · DOI: 10.26322/2013.7923.1505400572.03 · Publicado: Noviembre 2024